

Fregoli Sendromu

Fregoli Sendromu, sanrısalsal yanlış kimliklendirme sendromları arasında yer alan, nadir görülen bir psikiyatrik ve nöropsikiyatrik tablodur. İlk kez 1927 yılında Courbon ve Fail tarafından tanımlanmıştır.

Sendromun temel özelliği, kişinin çevresindeki farklı insanların aslında aynı tanıdık kişi olduğuna ve bu kişinin farklı kılıklara girerek karşısına çıktığına inanmasıdır. Yani kişi karşısındaki insanların görünüşlerinin farklı olduğunu fark edebilir; ancak onların gerçekte aynı kişi olduğunu düşünür. Bu nedenle Fregoli Sendromu, kişinin bir kişiyi diğer kişilerden ayırt etme ve kimliklendirme sürecindeki bozulmayla ilişkilendirilmektedir.

Fregoli Sendromunda kişi, birden fazla yabancıyı veya çevresindeki farklı kişileri tek bir tanıdık kişi olarak değerlendirebilir. Tanıdık kişinin kendisini takip ettiği, farklı kişilerin görünümüne bürünerek karşısına çıktığı veya kendisini gizlediği düşüncesi görülebilir. Bazı hastalarda bu yanlış tanımlama yalnızca bir kişiyle sınırlı kalmayıp birden fazla kişiyi kapsayabilir. Bu açıdan Fregoli Sendromu, yalnızca “birini başka biri sanma” şeklinde basit bir durum değildir; kişinin karşısındaki kişilerin kimliği hakkında güçlü ve gerçek olduğuna inandığı yanlış bir düşünce söz konusudur.

Fregoli Sendromu tek başına ortaya çıkabileceği gibi farklı psikiyatrik veya nörolojik durumlarla birlikte de görülebilir. İlk kaynaktaki incelenen 119 hastanın %52'sinde primer psikoz, %42'sinde ise sekonder psikoz ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Primer psikoz grubunda en sık görülen tanı şizofrenidir. Sekonder vakalarda ise özellikle nörolojik hastalıklar, inme ve travmatik beyin hasarı dikkat çekmektedir. Bu nedenle Fregoli Sendromu görülen bir kişide yalnızca psikiyatrik nedenler değil, altta yatabilecek nörolojik nedenler de dikkate alınmalıdır.

Fregoli Sendromunun oluşumunda beynin özellikle sağ yarımküresi ve frontal bölgeleriyle ilişkili bozuklukların önemli olabileceği düşünülmektedir. İlk kaynaktaki meta-analizde nörogörüntüleme yapılan hastalarda sağ taraflı beyin lezyonlarının sol taraflı lezyonlardan daha sık olduğu görülmüştür. İkinci kaynaktaki da sanrısalsal yanlış kimliklendirme sendromlarında sağ yarımküre ve özellikle sağ frontal bölgedeki lezyonların öne çıktığı belirtilmektedir. Bu bölgelerdeki işlev bozukluklarının kişinin aşinalık, gerçeklik değerlendirmesi ve anıların bütünleştirilmesi gibi süreçlerini etkileyerek yanlış kimliklendirmeye katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

Fregoli Sendromunun anlaşılmasında yüz tanıma ve duygusal değerlendirme süreçleri de önemlidir. İkinci kaynaktaki yüz tanımayla ilişkili ventral temporal bölgedeki fusiform yüz alanı ile duygusal düzenlemeyle ilişkili amigdalanın yanlış çalışmasının sanrısalsal yanlış kimliklendirmelerle ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Üçüncü kaynak ise Fregoli Sendromunu bir tür “hiper-kimliklendirme” durumu olarak

ele almakta ve kişinin belirli bir kişiye özgü olan benzersiz kimlik bilgisini ayırt etme yeteneğinin bozulabileceğini belirtmektedir.

Fregoli Sendromu bazı durumlarda ilk psikotik atak sırasında ortaya çıkabilir. İlk kaynağın sonuçlarına göre sekonder psikozu olan hastaların Fregoli Sendromunu ilk psikoz atağı sırasında yaşama olasılığı primer psikoz grubuna göre daha yüksektir. Ayrıca sekonder psikoz grubundaki hastaların daha yaşlı olduğu bildirilmiştir. Bu bulgular, özellikle ileri yaşta veya ilk psikotik atak sırasında Fregoli belirtileri gösteren kişilerde altta yatan nörolojik nedenlerin araştırılmasının önemini göstermektedir.

Tanı açısından Fregoli Sendromunu kesin olarak doğrulayan tek bir laboratuvar testi veya görüntüleme yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle ayrıntılı psikiyatrik, nörolojik ve bilişsel değerlendirme yapılması önemlidir. Gerekli durumlarda beyin görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir. Tedavide ise Fregoli Sendromu için tek ve kesin bir standart bulunmamaktadır; yaklaşım altta yatan nedene ve eşlik eden hastalıklara göre belirlenmektedir. Psikotik belirtilerin kontrolünde antipsikotik ilaçlar kullanılabilen, tedaviye dirençli bazı durumlarda ise farklı tedavi yöntemleri değerlendirilebilmektedir.

Sonuç olarak Fregoli Sendromu, kişinin farklı

insanları aynı tanıdık kişinin farklı görünümüleri olarak algıladığı nadir bir yanlış kimliklendirme sanrısıdır. Şizofreni gibi psikiyatrik hastalıklarla ilişkili olabileceği gibi inme ve travmatik beyin hasarı gibi nörolojik durumların ardından da ortaya çıkabilir. Özellikle sağ yarımküre ve frontal bölgelerle ilişkili bulgular, sendromun nörolojik yönünü ortaya koymaktadır. Bu nedenle Fregoli Sendromu yalnızca psikiyatrik bir belirti olarak değerlendirilmemeli, gerekli durumlarda altta yatan nörolojik ve bilişsel nedenler de araştırılmalıdır.

Kaynaklar:

- 1) Teixeira-Dias M, Dadwal AK, Bell V, Blackman G. Neuropsychiatric Features of Fregoli Syndrome: An Individual Patient Meta-Analysis. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2023 Spring;35(2):171-177. doi: 10.1176/appi.neuropsych.22010011. Epub 2022 Sep 29. PMID: 36172691.
- 2) Bashir S, Mars JA, Gunturu S. Delusional Misidentification Syndrome. 2024 Dec 11. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan-. PMID: 39808042.
- 3) Kochuparackal T, Simon AE. A "contemporary" case of frégoli syndrome. Prim Care Companion CNS Disord. 2012;14(1):PCC.11101227. doi: 10.4088/PCC.11101227. Epub 2012 Jan 26. PMID: 22690358; PMCID: PMC3357570.

Ali Bocakkıtay/ Founder, Wionpav Labs/ Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University